准看護師試験 過去問題集（眼科・視覚領域関連問題）

本ドキュメントは、令和 2 年度（2020 年）～令和 7 年度（2025 年）の准看護師試験公式問題および公式解答から、眼科疾患、眼の解剖・生理、検査、治療、点眼・洗眼、看護、全身疾患に伴う眼症状、選択肢に眼科用語が含まれる問題を抽出・整理したものです。

【2025 年実施（令和 7 年度）】

① 25A10　脂溶性ビタミンと眼症状（夜盲症）

> **【問題】**
> 脂溶性ビタミンはどれか。
>
> 1. ビタミン A
> 2. ビタミン B1
> 3. ビタミン C
> 4. 葉酸

【正解】1　ビタミン A

【選択肢ごとの解説】

- **1 ：○（正解）**

ビタミン A は、脂溶性ビタミン（A・D・E・K）の 1 つです。網膜で光を感じるロドプシンの構成成分であり、欠乏すると夜盲症（鳥目）や角膜乾燥症を引き起こします。ビタミン A は、脂溶性ビタミン。ビタミン A 欠乏症：夜盲症・角膜乾燥症。

- **2 ：×（誤り）**

ビタミン B1 は、水溶性ビタミンです。炭水化物（糖質）の代謝に関与しており、欠乏すると脚気やウェルニッケ脳症を引き起こします。ビタミン B1 は、水溶性ビタミン。ビタミン B1 欠乏症：脚気・ウェルニッケ脳症。

- **3 ：×（誤り）**

ビタミン C は、水溶性ビタミンです。コラーゲンの合成に関与しており、欠乏すると毛細血管が脆くなり出血しやすくなる壊血病を引き起こします。ビタミン C は、水溶性ビタミン。ビタミン C 欠乏症：壊血病。

- **4 ： ×（誤り）**

葉酸は、水溶性ビタミン（ビタミン B 群の一種）です。赤血球の形成や DNA 合成に関与し、欠乏すると巨赤芽球性貧血や胎児の神経管閉鎖障害の原因となります。葉酸は、水溶性ビタミン。葉酸欠乏症：巨赤芽球性貧血。

【眼科との関連】 ビタミン A は網膜視細胞の光受容物質（ロドプシン）の維持や角膜上皮の正常化に不可欠であり、欠乏による「夜盲症（暗順応障害）」や「角膜乾燥」など眼科領域の機能障害と直接関連するため抽出しました。

② 25A96　頭蓋内圧亢進症状と脳神経（眼瞼下垂）

> **【問題】**
> 頭蓋内圧亢進症状はどれか。
>
> 1. クスマウル呼吸
> 2. 眼瞼下垂
> 3. 血圧上昇
> 4. 頻脈

【正解】 3　血圧上昇

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

クスマウル呼吸は、糖尿病性ケトアシドーシスや尿毒症などの代謝性アシドーシス時にみられる、深大で規則的な呼吸パターンです。頭蓋内圧亢進時には、徐脈・徐呼吸やチェーン-ストークス呼吸（クッシング現象）が特徴です。

- **2 ： ×（誤り）**

眼瞼下垂は、動眼（第 III 脳神経）神経麻痺や重症筋無力症、ホーネル症候群などで生じる上眼瞼の下垂症状です。頭蓋内圧亢進の代表的徴候（クッシング 3 徴候：血圧上昇・徐脈・徐呼吸、乳頭水腫、頭痛、噴出性嘔吐）としては優先されません。

- **3 ： ○（正解）**

血圧上昇は、頭蓋内圧亢進により脳血流を維持しようとして収縮期血圧が著しく上昇するクッシング現象の典型的な主要症状です。頭蓋内圧亢進症状：血圧上昇・徐脈・徐呼吸（クッシング徴候）、頭痛、噴出性嘔吐、乳頭水腫。

- **4 ： ×（誤り）**

頻脈ではなく徐脈がみられます。脳圧亢進に伴う自律神経反射（クッシング反射）により心拍数が減少します。

【眼科との関連】 誤答選択肢 2 に眼科・神経眼科領域の重要症状である「眼瞼下垂（動眼神経障害や眼輪筋・上眼瞼挙筋障害）」が含まれるため抽出しました。

③ 25A102　洗眼時の看護

> **【問題】**
> 洗眼時の看護について、適切なのはどれか。
>
> 1. 顎に受水器をあてる。
> 2. 洗眼時の水の温度は体温程度とする。
> 3. 異物が入ったときは生理食塩水を 5 mL 用いる。
> 4. 洗眼液は角膜にあたるようにする。

【正解】 2　洗眼時の水の温度は体温程度とする。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

受水器（洗眼用受け皿）は、洗浄液がこぼれないように患側の「頬（ほお）」に密着させてあてます。顎にあてると洗眼液が溢れて衣服や床を濡らしてしまいます。

- **2 ： ○（正解）**

洗眼液の温度は、眼粘膜への冷刺激や痛みを防ぐため「体温程度（約 36〜37°Cのぬるま湯・生理食塩水）」に調整するのが適切です。洗眼液の温度＝体温程度（約 36〜37°C）。

- **3 ： ×（誤り）**

化学薬品や異物が入った場合の洗眼では、5 mL では不十分であり、微温湯または生理食塩水で十分量（通常数分間〜15 分以上、大量の流動水）を流し洗う必要があります。

- **4 ： ×（誤り）**

洗眼液を直接角膜（黒目）に強く当てると角膜上皮損傷や痛みを引き起こすため、水流は「内眼角（目頭）から外眼角（目尻）」に向けて結膜嚢（結膜円蓋部）に流します。

【眼科との関連】 眼科看護の基本技術である「洗眼（水温、受水器の位置、角膜損傷防止、水流の方向）」に関する直接的な問題であるため抽出しました。

④ 25A103　加齢黄斑変性の症状

> **【問題】**
> 加齢黄斑変性の症状はどれか。
>
> 1. 羞明・霧視
> 2. 飛蚊症
> 3. 角膜混濁（牛眼）
> 4. 視力低下

【正解】 4　視力低下

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

羞明（まぶしさ）や霧視（かすみ目）は、白内障や角膜炎、虹彩毛様体炎（ブドウ膜炎）などで代表的な初期症状です。

- **2 ： ×（誤り）**

飛蚊症は、生理的硝子体混濁や後部硝子体剥離、網膜剥離の前兆としてみられる「蚊や糸くずが飛んでいるように見える」症状です。

- **3 ： ×（誤り）**

角膜混濁（牛眼）は、乳幼児の先天緑内障などで眼圧亢進により眼球が拡大・角膜が混濁する状態です。

- **4 ： ○（正解）**

加齢黄斑変性は、網膜の中心部である黄斑部が加齢に伴い障害される疾患で、主症状は「変視症（物がゆがんで見える）」「中心暗点」「進行性の視力低下」です。加齢黄斑変性の 3 大症状：視力低下・変視症・中心暗点。

【眼科との関連】 中途失明の主要原因である眼科疾患「加齢黄斑変性」の病態と主要症状（視力低下）に関する直接問題であるため抽出しました。

⑤ 25A104　難聴の種類と視覚・感覚器の比較

> **【問題】**
> 難聴について、正しいのはどれか。
>
> 1. 感音性難聴は外耳に障害がある。
> 2. 突発性難聴の多くは両側性である。
> 3. 老人性難聴は感音性難聴である。
> 4. 伝音性難聴は内耳に障害がある。

【正解】 3　老人性難聴は感音性難聴である。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

感音性難聴は、内耳（蝸牛）や聴神経、脳の聴覚中枢の障害によって生じます。外耳や中耳の障害で生じるのは「伝音性難聴」です。

- **2 ： ×（誤り）**

突発性難聴は、原因不明で突然に発症する高度の難聴で、ほとんどが「片側性（一律片耳）」です。

- **3 ： ○（正解）**

老人性難聴は、加齢に伴い内耳の有毛細胞や聴神経が退行性変性することで生じる「感音性難聴」で、特に高音域から障害されます。加齢性聴覚障害＝感音性難聴（高音域から低下）。

- **4 ： ×（誤り）**

伝音性難聴の障害部位は「外耳および中耳」です。内耳の障害は「感音性難聴」です。

【眼科との関連】 頭部感覚器（視覚・聴覚）の加齢性変化の理解において、視覚の老視・白内障と並び比較される耳鼻咽喉科・感覚器領域の問題として抽出しました。

⑥ 25B19　眼の疾患と病態（糖尿病網膜症）

> **【問題】**
> 眼の疾患について、正しいのはどれか。
>
> 1. 白内障は手術しても治らない。
> 2. 網膜剥離は加齢で起きる。

3. 麦粒腫（ものもらい）は腫瘍である。

4. 糖尿病は網膜症を起こす。

【正解】 4　糖尿病は網膜症を起こす。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

白内障は、水晶体が混濁する疾患ですが、超音波水晶体乳化吸引術および眼内レンズ挿入術（手術治療）により著しく視力が回復・改善します。

- **2 ： ×（誤り）**

網膜剥離は加齢現象だけでなく、網膜裂孔（アトピー性皮膚炎での眼摩擦、頭部眼球打撲、高度近視など）により生じます。加齢のみに起因する疾患ではありません。

- **3 ： ×（誤り）**

麦粒腫（いわゆる「ものもらい」「めばちこ」）は、睫毛の毛嚢やマイボーム腺・摩脱腺に黄色ブドウ球菌などが感染して起こる「急性化膿性炎症」であり、腫瘍ではありません。

- **4 ： ○（正解）**

糖尿病の三大慢性合併症（し・め・じ：神経障害・目/網膜症・腎症）の 1 つとして「糖尿病網膜症」があり、成人の中途失明原因の上位を占めます。糖尿病の 3 大合併症：糖尿病網膜症（微細血管障害）。

【眼科との関連】 白内障、網膜剥離、麦粒腫、糖尿病網膜症という代表的な眼科疾患・病態の正誤を網羅的に問う直接的な問題であるため抽出しました。

⑦ 25B42　空気感染予防と個人防護具（ゴーグルの役割）

【問題】
空気感染（飛沫核）予防で、最も有効なのはどれか。

1. N95 マスク
2. ゴーグル
3. サージカルマスク
4. ガウン

【正解】 1　N95 マスク

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ○（正解）**

空気感染（結核、麻しん、水痘など）を起こす微粒子（5μm 未満の飛沫核）の吸入を防ぐため、密着性の高い「N95 マスク」の着用が最も有効で推奨されます。空気感染予防＝N95 マスク着用。

- **2 ： ×（誤り）**

ゴーグル（保護眼鏡・アイシールド）は、患者の血液・体液・分泌物が看視者・看護師の「眼粘膜」に飛散・付着するのを防ぐ個人防護具（PPE）です。空気感染粒子自体の呼吸器侵入予防ではありません。

- **3 ： ×（誤り）**

サージカルマスクは飛沫感染（5μm 以上の大きな唾液飛沫等）の予防には有効ですが、粒子が非常に小さい空気感染（飛沫核）を防ぐ密閉性能はありません。

- **4 ： ×（誤り）**

ガウンは接触感染予防や血液・体液の衣類・皮膚への汚染防止に用いられます。

【眼科との関連】 選択肢 2 の「ゴーグル（保護眼鏡）」は、感染症処置時の眼粘膜保護および眼科的防護用具（PPE）として重要な役割を持つため抽出しました。

⑧ 25B89　抗がん薬治療と毛髪・眉毛・まつ毛の脱落

> **【問題】**
> A さん（20 歳、女性）。急性骨髄性白血病と診断された。 3 週間前から抗がん薬（剤）治療を受け、「髪の毛が抜けてきた。」と泣いている。最も適切な関わりはどれか。
>
> 1. 鏡を見ないように伝える。
> 2. スキンヘッドのよさを伝える。
> 3. 容姿補整の情報提供をする。
> 4. 眉毛やまつ毛も抜けることを情報提供する。

【正解】 3　容姿補整の情報提供をする。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

鏡を不自然に避けさせる対応は、患者の不安や現実受容を阻害し悲嘆に配慮していません。

- **2 ： ×（誤り）**

若い女性患者の脱毛によるショックや外見変化（ボディイメージの混乱）に対して不適切で配慮を欠く言葉かけです。

- **3 ： ○（正解）**

抗がん薬の副作用による脱毛・外見変化に対し、医療用ウィッグや帽子、メイクアップなどの「容姿補整（アピアランスケア）」の情報を提供し寄り添うことが最も適切です。脱毛対策＝アピアランスケア（ウィッグ・帽子等の情報提供）。

- **4 ： ×（誤り）**

現在頭髪の脱毛で著しく動揺している段階で、さらに眉毛やまつ毛（眼周辺の被毛）の脱落リスクを追撃的に伝えるのは患者の精神的苦痛を無用に強めるため不適切です。

【眼科との関連】 選択肢 4 に含まれる「まつ毛（睫毛）」は眼球をゴミや異物から保護する眼付属器の重要な構成要素であり、外見補整や眼刺激対策に関連するため抽出しました。

⑨ 25B102　眼底検査を受ける患者の看護（散瞳薬と緑内障）

> **【問題】**
> 眼底検査を受ける患者の看護について、適切なのはどれか。
>
> 1. 検査前に緑内障の有無を確認する。
> 2. 散瞳薬は検査直前に点眼する。
> 3. 室内を明るくする。
> 4. 検査後 1 時間で車の運転は可能と説明する。

【正解】 1　検査前に緑内障の有無を確認する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ○（正解）**

眼底検査で使用する「散瞳薬（抗コリン薬など）」は散瞳作用により隅根部を狭め、閉塞隅角緑内障の患者に投与すると急性緑内障発作（眼圧急昇）を誘発する恐れがあるため、事前に緑内障の既往・有無を確認します。散瞳薬点眼＝事前に緑内障の有無の確認が必須。

- **2 ： ×（誤り）**

散瞳薬の効果が十分に現れる（瞳孔が開く）までには点眼後 20〜30 分程度かかるため、検査直前ではなく「検査前（20〜30 分前）」に点眼します。

- **3 ： ×（誤り）**

眼底検査時および検査後は、散瞳により目に入る光量が増えて非常に眩しさを感じる（羞明）ため、検査室の照明は「暗く（薄暗く）」保持します。

- **4 ： ×（誤り）**

散瞳薬の作用は数時間（約 4〜6 時間）持続し、まぶしさやピント調節障害が残るため、検査当日は「車の運転や危険な機械の操作」を禁止します。

【眼科との関連】 眼科の代表的精密検査である「眼底検査」の手順、散瞳薬の作用、緑内障禁忌、検査後指導に関する直接問題であるため抽出しました。

⑩ 25B103　流行性角結膜炎の症状と感染対策

> **【問題】**
> 流行性角結膜炎について、正しいのはどれか。
>
> 1. エンテロウイルスの感染によって起こる。
> 2. 潜伏期間は 1 〜 2 日である。
> 3. 接触感染はしない。
> 4. 多量の眼脂がみられる。

【正解】 4　多量の眼脂がみられる。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

流行性角結膜炎（はやり目）の原因病原体は「アデノウイルス（主に 8, 19, 37 型など）」です。（※急性出血性結膜炎がエンテロウイルス 70 型やコクサッキーウイルス A24 変異株です）。

- **2 ： ×（誤り）**

流行性角結膜炎の潜伏期間は「約 8〜14 日（約 1〜2 週間）」であり、1〜2 日ではありません。

- **3 ： ×（誤り）**

アデノウイルスは非常に感染力が強く、眼脂（目やに）や涙液を介した「接触感染（手指やタオルの共有）」により学校や施設内で集団感染を引き起こします。

- **4 ： ○（正解）**

流行性角結膜炎の主症状は「多量の眼脂（目やに）」「結膜の著しい充血」「眼瞼浮腫（まぶたの腫れ）」「耳前リンパ節腫脹・圧痛」です。流行性角結膜炎の主症状：多量の眼脂・結膜充血・耳前リンパ節腫脹。

【眼科との関連】 眼科感染症である「流行性角結膜炎（アデノウイルス感染）」の病態、主症状（眼脂・結膜充血）、接触感染予防に関する直接問題であるため抽出しました。

【2024 年実施（令和 6 年度）】

⑪ 24A05　眼の解剖生理（毛様体と遠近調節）

> **【問題】**
> 眼の遠近調節を行うのはどれか。
>
> 1. 毛様体
> 2. 硝子体
> 3. 網膜
> 4. 上直筋

【正解】 1　毛様体

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ○（正解）**

毛様体には毛様体筋があり、毛様体筋の収縮・弛緩とチン小帯の弛緩・緊張によって「水晶体」の厚みを変化させ、光の屈折度を調節して遠近のピントを合わせます（近所を見る時は毛様体筋が収縮し水晶体が厚くなる）。ピント（遠近）調節＝毛様体（毛様体筋・水晶体）。

- **2 ： ×（誤り）**

硝子体は、眼球内部の大部分を占める無色透明なゼリー状物質で、眼球の形状（内圧）保持や光の透過を行いますが、遠近調節機能はありません。

- **3 ： ×（誤り）**

網膜は眼球最内層にある受容器で、視細胞（桿体・錐体）が光刺激を電気信号に変換して視神経へ伝える役割を持ちます。

- **4 ： ×（誤り）**

上直筋は、眼球を上方（上向き）に動かす外眼筋の 1 つです。

【眼科との関連】 眼球の解剖生理における「遠近調節メカニズム（毛様体筋・水晶体）」に関する直接問題であるため抽出しました。

⑫ 24A10　ビタミンとその欠乏症（ビタミン A）

> **【問題】**
> ビタミンとその欠乏症の組合せで、正しいのはどれか。
>
> 1. ビタミン A ―― 骨軟化症
> 2. ビタミン B12 ―― 巨赤芽球貧血（悪性貧血）
> 3. ビタミン D ―― 脚気
> 4. ビタミン E ―― 壊血病

【正解】 2　ビタミン B12 ―― 巨赤芽球貧血（悪性貧血）

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

ビタミン A の欠乏症は「夜盲症（暗順応障害）」や角膜乾燥症です。骨軟化症はビタミン D 欠乏による疾患です。

- **2 ： ○（正解）**

ビタミン B12 や葉酸が欠乏すると、DNA 合成障害により赤芽球の成熟が停止し「巨赤芽球性貧血（悪性貧血）」を引き起こします。ビタミン B12 欠乏症＝巨赤芽球性貧血。

- **3 ： ×（誤り）**

ビタミン D の欠乏症は「くる病（小児）」や「骨軟化症（成人）」です。脚気はビタミン B1 欠乏によります。

- **4 ： ×（誤り）**

ビタミン E の欠乏症は未熟児貧血や溶血性貧血などです。壊血病はビタミン C 欠乏によります。

【眼科との関連】 選択肢 1 の「ビタミン A」は暗所視に関わる網膜視物質ロドプシンの生成に不可欠であり、欠乏すると眼科症状「夜盲症」を発症するため抽出しました。

⑬ 24A14　自律神経薬の作動と瞳孔変化

> **【問題】**

> アドレナリン作動薬の作用はどれか。
>
> 1. 縮瞳
> 2. 血圧上昇
> 3. 気管支収縮
> 4. 心拍数減少

【正解】2　血圧上昇

【選択肢ごとの解説】

- **1：×（誤り）**

アドレナリン作動薬（交感神経刺激薬）は、瞳孔散大筋を収縮させて「散瞳」を引き起こします。「縮瞳」を起こすのは副交感神経刺激薬（コリン作動薬など）です。

- **2：○（正解）**

アドレナリン作動薬は、血管平滑筋の α1 受容体を刺激して末梢血管を収縮させ「血圧上昇」をもたらします。アドレナリン作動薬＝交感神経興奮（血圧上昇・心拍数増加・気管支拡張・散瞳）。

- **3：×（誤り）**

アドレナリン作動薬は気管支平滑筋の β2 受容体を刺激して「気管支拡張」を起こします。

- **4：×（誤り）**

心臓の β1 受容体を刺激して「心拍数増加（心機能亢進）」を引き起こします。

【眼科との関連】 交感神経・副交感神経刺激薬が及ぼす「瞳孔の運動（散瞳・縮瞳）」は眼科薬理学の基本知識であるため抽出しました。

⑭ 24A84　甲状腺機能亢進症（バセドウ病）の症状と眼球突出

> **【問題】**
> 甲状腺機能亢進症の患者にみられるのはどれか。
>
> 1. 動悸
> 2. 体重増加
> 3. 便秘

> 4. 粘液水腫

【正解】 1　動悸

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ○（正解）**

甲状腺機能亢進症（バセドウ病）では、甲状腺ホルモン過剰により代謝が著しく亢進し、「動悸」「頻脈」「手足の震え（手指振戦）」「体重減少」「微熱・多汗」「眼球突出」などの症状が現れます。バセドウ病＝代謝亢進（動悸・体重減少・多汗・眼球突出）。

- **2 ： ×（誤り）**

代謝亢進により「体重減少」をきたします。（※体重増加は甲状腺機能低下症の特徴です）。

- **3 ： ×（誤り）**

腸管蠕動運動が亢進するため「下痢・多動」がみられます。（※便秘は低下症の症状です）。

- **4 ： ×（誤り）**

粘液水腫（非小窩性浮腫）は「甲状腺機能低下症（クレチン病・橋本病）」の代表的症状です。

【眼科との関連】 甲状腺機能亢進症（バセドウ病）は、眼窩後方組織の炎症・浮腫により「眼球突出（バセドウ病眼症）」を合併する代表的な全身疾患であるため抽出しました。

⑮ 24A98　点眼時の看護と手技

> **【問題】**
> 点眼時の看護について、適切なのはどれか。
>
> 1. 複数の点眼薬を用いるときは 1 分間の間隔をあける。
> 2. 眼軟膏は最初に使用する。
> 3. 点眼後はまばたきを繰り返すように促す。
> 4. 点眼薬は 1 回に 1 滴を滴下する。

【正解】 4　点眼薬は 1 回に 1 滴を滴下する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

2 種類以上の点眼薬を併用する場合、前にさした薬が洗い流されるのを防ぐため「5 分以上」の間隔をあけて点眼します。

- **2 ： ×（誤り）**

点眼薬と眼軟膏を併用する場合、眼軟膏の油分が水性点眼薬の吸収を妨げるため「点眼薬を先に行い、最後に眼軟膏」を点入します。

- **3 ： ×（誤り）**

点眼直後にまばたきを繰り返すと、薬液が涙道を通って鼻腔・全身に流出してしまうため、点眼後は「静かに閉眼し、目頭（涙のう部）を軽く圧迫」します。

- **4 ： ○（正解）**

結膜嚢に保持できる液体量はわずか（約 0.03 mL）であり、点眼薬は「1 回につき 1 滴」で十分な薬効が得られます（多量にさしても溢れるだけです）。点眼＝1 回 1 滴、併用時は 5 分以上あける、点眼後は目頭圧迫。

【眼科との関連】 眼科看護・与薬技術の最重要項目である「点眼の基本手技（1 回 1 滴、間隔 5 分、点眼薬と軟膏の順序、点眼後閉眼・圧迫）」に関する直接問題であるため抽出しました。

⑯ 24A99　眼底検査を受ける患者への説明と看護

> **【問題】**
> 眼底検査を受ける患者への説明について、適切なのはどれか。
>
> 1. 「入院が必要です。」
> 2. 「アレルギーの有無は問いません。」
> 3. 「検査中は部屋を明るくします。」
> 4. 「散瞳薬を使用しますので、当日の車の運転は控えてください。」

【正解】 4　「散瞳薬を使用しますので、当日の車の運転は控えてください。」

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

眼底検査は、外来の処置室で短時間で行うことができる日帰り検査であり、入院の必要はありません。

- **2 ： ×（誤り）**

使用する散瞳薬や検査機器、消毒薬等に対する散瞳薬禁忌（緑内障）やアレルギーの有無はあらかじめ必ず問診・確認します。

- **3 ： ×（誤り）**

眼底検査は瞳孔から眼球奥を観察するため、また散瞳状態での羞明（まぶしさ）を和らげるために「部屋を薄暗く（暗室）」して行います。

- **4 ： ○（正解）**

散瞳薬の効果により数時間は瞳孔が開いたままとなり、光を強く眩しく感じたりピントが合わなくなったりするため、「検査当日の自転車・自動車の運転」は大変危険であり禁止・注意喚起します。眼底検査後＝散瞳持続のため車・バイクの運転は禁止。

【眼科との関連】 眼底検査における散瞳薬投与、生活指導（危険防止・運転禁止）、環境調整（暗室）に関する直接問題であるため抽出しました。

⑰ 24B42　防護具の目的と眼粘膜保護（ゴーグル）

> **【問題】**
> 空気感染（飛沫核）予防で、最も有効なのはどれか。
>
> 1. N95 マスク
> 2. ゴーグル
> 3. サージカルマスク
> 4. ガウン

【正解】 1　N95 マスク

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ○（正解）**

結核や麻しんなどの空気感染病原体（飛沫核）を遮断するためには、粒子捕集効率の高い N95 マスク着用が不可欠です。

- **2 ： ×（誤り）**

ゴーグルは眼粘膜への体液・血液の飛散を防ぐ PPE（個人防護具）です。呼吸器からの空気感染自体の予防具ではありません。

- **3 ： ×（誤り）**

サージカルマスクは飛沫感染予防用です。

- **4 ： ×（誤り）**

ガウンは接触感染予防用です。

【眼科との関連】 選択肢 2 のゴーグルが、医療従事者の「眼粘膜」を血液・体液汚染から護る防衛器具として選択肢に記載されているため抽出しました。

⑱ 24B72　黄疸の初発観察部位（眼球結膜）

> **【問題】**
> 黄疸が最初に観察されるのはどれか。
>
> 1. 眼球結膜
> 2. 顔面
> 3. 体幹
> 4. 四肢

【正解】 1　眼球結膜

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ○（正解）**

血中ビリルビン値が上昇（約 2.0 mg/dL 以上）した際、ビリルビンは弾性繊維と結合しやすいため、弾性繊維が豊富な「眼球結膜（白目）」に最も早く黄色線調・黄染（黄疸）として現れます。黄疸の初発検出部位＝眼球結膜。

- **2 ： ×（誤り）**

眼球結膜に黄染が現れた後、黄疸が進行すると皮膚（顔面・胸部・全身）へ黄染が広がっていきます。

- **3 ： ×（誤り）**

顔面や手足よりも体幹・全身への黄染は遅れて出現・認知されます。

- **4 ： ×（誤り）**

四肢の皮膚黄染は、高ビリルビン血症がより進行した段階で見られます。

【眼科との関連】 肝胆道系疾患や溶血性疾患の診察において、「眼球結膜（しろめ）」の観察が黄色調変化（黄疸）の早期発見に不可欠であるため抽出しました。

⑲ 24B98　洗眼時の看護と手順

> **【問題】**
> 洗眼時の看護について、適切なのはどれか。
>
> 1. 洗眼液には蒸留水を使用する。
> 2. 洗眼液は冷却しておく。
> 3. 受水器は頬にあてる。
> 4. 勢いよく洗眼液を眼にあてる。

【正解】 3　受水器は頬にあてる。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

蒸留水は低浸透圧であり眼粘膜に強い痛みや刺激を与えるため、洗眼には浸透圧が等しい「生理食塩水」または洗眼用微温湯を使用します。

- **2 ： ×（誤り）**

冷やした液は冷刺激・痛みを引き起こすため、洗眼液の温度は「体温程度（36〜37°C）」に調整します。

- **3 ： ○（正解）**

洗眼液を受ける受水器（洗眼器）は、液が首筋や衣服へ流れないように患側の「頬（ほお）」に隙間なく密着させてあてます。受水器の位置＝患側の頬。

- **4 ： ×（誤り）**

強い水流を眼球に直射すると角膜上皮を傷つける恐れがあるため、内眼角（目頭）側から流し、やさしい水流で洗眼します。

【眼科との関連】 洗眼技術（受水器の保持位置、洗眼液の種類、水温、角膜保護）に関する直接問題であるため抽出しました。

⑯ 24B99　散瞳薬を用いる検査（眼底検査）

> **【問題】**
> 散瞳薬を用いて行う検査はどれか。

1. 眼底検査
2. 眼圧検査
3. 視野検査
4. 涙液分泌（涙液）検査

【正解】 1　眼底検査

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ○（正解）**

眼底検査では、瞳孔を大きく開く「散瞳薬（ミドリンＰ等）」を点眼して、透光体を通じて網膜・視神経乳頭・網膜血管の状態を精密に観察します。散瞳薬を使用する検査＝眼底検査。

- **2 ： ×（誤り）**

眼圧検査（トノメーター）は、角膜に微小な空気を吹きかけたり接触させたりして房水圧力を測定する検査で、点眼麻酔薬を使うことはあっても散瞳薬は使いません。

- **3 ： ×（誤り）**

視野検査（ゴールドマン視野計や自動視野計）は、視界の広さと感度を測る検査で、散瞳させる必要はありません。

- **4 ： ×（誤り）**

涙液分泌機能検査（シルマーテスト）は、下眼瞼に試験紙を挟んで涙の分泌量を測定する検査です。

【眼科との関連】 眼科処置薬である「散瞳薬」とそれを用いて実施する代表的眼科検査「眼底検査」を直接問う問題であるため抽出しました。

㉑ 24B120　老視の生理的変化（水晶体）

【問題】
老視について、正しいのはどれか。

1. 60 歳を過ぎる頃から出現する。
2. 水晶体の弾力性が低下する。
3. 羞明感がみられる。
4. 遠くの物体が見えにくくなる。

【正解】 2　水晶体の弾力性が低下する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

老視（老眼）は、一般的に「40 歳代半ば頃」から自覚症状（手元が見えにくい）が現れ始めます。60 歳からではありません。

- **2 ： ○（正解）**

老視の主因は、加齢に伴い「水晶体の弾力性・硬化」が起こり、さらに毛様体筋の調節力が低下することによって近所にピントを合わせられなくなる現象です。老視の原因＝水晶体の弾力性低下・毛様体筋調節力低下。

- **3 ： ×（誤り）**

羞明感（まぶしさ）は白内障や角膜炎などの症状であり、老視の直接的症状ではありません。

- **4 ： ×（誤り）**

老視でみづらくなるのは「近くの物体（近所）」であり、遠くの視力は保たれます。

【眼科との関連】 屈折・調節異常である「老視（老眼）」の発症機序（水晶体の弾力性低下）に関する直接問題であるため抽出しました。

【2023 年実施（令和 5 年度）】

㉒ 23A24　緑内障発作の急性症状（眼痛）

> **【問題】**
> 緑内障発作でみられる症状はどれか。
>
> 1. 発熱
> 2. 下痢
> 3. めまい
> 4. 眼痛

【正解】 4　眼痛

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

緑内障発作で全身性の発熱症状は通常起こりません。

- **2 ： ×（誤り）**

下痢ではなく、急激な眼圧上昇による自律神経刺激で「悪心・嘔吐」を伴うことがあります。

- **3 ： ×（誤り）**

めまい（回転性めまいなど）はメニエール病や内耳疾患、脳幹・小脳障害でみられます。

- **4 ： ○（正解）**

急性閉塞隅角緑内障発作では、房水排出路が急激に閉塞して眼圧が著しく急昇（正常値 10〜21 mmHg のところ 50 mmHg 以上）し、「激しい眼痛」「同側の頭痛」「角膜混濁・かすみ目」「視力急降下」「悪心・嘔吐」を引き起こします。緑内障発作の症状＝激しい眼痛・頭痛・悪心嘔吐・視力低下。

【眼科との関連】 眼科緊急疾患である「急性緑内障発作」の代表的徴候（激しい眼痛）に関する直接問題であるため抽出しました。

㉓ 23A84　甲状腺機能亢進症患者の看護と眼球突出

> **【問題】**
> 甲状腺機能亢進症患者の看護について、適切なのはどれか。
>
> 1. テタニー症状の観察をする。
> 2. 低エネルギー食とする。
> 3. 積極的に運動をすすめる。
> 4. 頸部腫脹にはスカーフをすすめる。

【正解】 4　頸部腫脹にはスカーフをすすめる。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

テタニー症状（低カルシウム血症による手足の痺れ・痙攣）は、副甲状腺機能低下症や甲状腺手術時の副甲状腺誤摘出で問題となります。

- **2 ： ×（誤り）**

甲状腺機能亢進症では基礎代謝が著しく高まり消費エネルギーが増大するため、「高エネルギー・高たんぱく食」を提供します。

- **3 ： ×（誤り）**

頻脈・心負荷が高まっているため、安静を保ち過度の運動や労作は避けるよう指導します。

- **4 ：〇（正解）**

甲状腺腫大（首の腫れ）や眼球突出などの外見変化（ボディイメージの変化）に対して羞恥心を抱く患者に対し、スカーフやハイネック衣服の使用を提案するなどの工夫・社会的配慮が有効です。甲状腺腫大・眼球突出＝ボディイメージ配慮（スカーフ等提案）。

【眼科との関連】 甲状腺機能亢進症（バセドウ病）の二大特徴的外見変化である「甲状腺腫大」および「眼球突出」に対する精神的ケア・看護援助に関連するため抽出しました。

㉔ 23A98　網膜剥離患者の看護と体位管理

> **【問題】**
> 網膜剥離の患者の看護について、適切なのはどれか。
>
> 1. 手術前は安静の必要性はないことを伝える。
> 2. 手術後の体位保持に伴う苦痛を緩和する。
> 3. 手術後に眼痛があれば、眼圧低下に注意する。
> 4. 手術後、翌日から洗顔や洗髪ができることを説明する。

【正解】 2　手術後の体位保持に伴う苦痛を緩和する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ：×（誤り）**

術前に眼球を大きく動かすと網膜剥離の範囲が拡大する危険があるため、「安静（眼球安静）」を守る必要があります。

- **2 ：〇（正解）**

網膜剥離の手術（硝子体手術やバックリング術＋ガス復元）後は、剥離した網膜を復元させるために特定体位（俯臥位/うつぶせ体位など）を数日間持続保持する必要があり、腰痛や固定部位の苦痛緩和ケアが非常に重要です。網膜剥離術後＝特殊体位保持（うつぶせ等）に伴う苦痛緩和。

- **3 ：×（誤り）**

術後の激しい眼痛は、手術侵襲や前房出血、硝子体注入ガス膨張等による「眼圧上昇（高眼圧）」を疑うサインです。眼圧低下ではありません。

- **4 ：×（誤り）**

手術創からの術後眼内炎（感染）を予防するため、術後一定期間（通常 1〜2 週間程度）は「洗顔・洗髪」が制限されます。

【眼科との関連】 眼科主要手術である「網膜剥離手術」の術前・術後看護（眼球安静、特定体位保持、眼圧モニタリング、洗眼洗髪制限）に関する直接問題であるため抽出しました。

㉕ 23A99　点眼手技と涙小管流出防止

> **【問題】**
> 点眼について、適切なのはどれか。
>
> 1. 複数の点眼薬を使用する場合は、 1 分間あけて点眼する。
> 2. 複数の点眼薬を使用する場合は、油性点眼薬から水溶性点眼薬の順で使用する。
> 3. 点眼後は、目頭を軽く圧迫し涙小管内へ流出しないようにする。
> 4. 点眼薬は、 1 回に 2 ～ 3 滴を滴下する。

【正解】 3　点眼後は、目頭を軽く圧迫し涙小管内へ流出しないようにする。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

2 種類以上の点眼薬を使う場合、先にさした薬が薄まったり流されたりするのを防ぐため「5 分以上」の間隔を空けます。

- **2 ： ×（誤り）**

水性点眼薬と油性点眼薬（または眼軟膏）の併用では、油分が水分の吸収を阻害するため「水性点眼薬を先」に使い、油性点眼薬や眼軟膏を後に使用します。

- **3 ： ○（正解）**

点眼直後、内眼角（目頭）付近にある「涙のう部・涙小管」を指で軽く圧迫することで、薬液が鼻腔に排出されて全身副作用（β 遮断薬による徐脈など）を起こすのを防ぎ、眼局所での保持効果を高めます。点眼後＝目頭（涙のう部）の軽圧迫・閉眼。

- **4 ： ×（誤り）**

結膜嚢の容量には限界があるため、点眼量は「1 回につき 1 滴」が基本です。

【眼科との関連】 点眼療法の基本手技（目頭・涙小管圧迫による全身副作用防止、点眼間隔、投与順序）に関する直接問題であるため抽出しました。

㉖ 23A121　視力低下を伴う各種眼疾患

> **【問題】**

> 視力低下を伴う疾患について、正しいのはどれか。
>
> 1. 老視は 60 歳代から現れる。
> 2. 老人性白内障は水晶体が混濁する。
> 3. 緑内障は眼圧が下がる。
> 4. 加齢黄斑変性は失明の原因ではない。

【正解】 2　老人性白内障は水晶体が混濁する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

老視は水晶体の調節力低下により「40 歳代半ば」から手元が見えにくくなります。

- **2 ： ○（正解）**

老人性白内障は、加齢に伴いレンズの役割を果たす「水晶体」のタンパク質が白く濁り（混濁）、光が十分届かなくなってかすみ目や徐々に進行する視力低下をきたす疾患です。老人性白内障＝水晶体の混濁。

- **3 ： ×（誤り）**

緑内障は、房水循環障害等により「眼圧が上昇（正常眼圧緑内障も含め相対的高眼圧）」して視神経障害・視野欠損を起こす疾患です。眼圧は下がりません。

- **4 ： ×（誤り）**

加齢黄斑変性は、欧米および日本において「中途失明の主要な原因疾患の 1 つ」です。

【眼科との関連】 高齢者の視力障害を引き起こす主要眼疾患（白内障、緑内障、加齢黄斑変性、老視）の定義・病態を総合的に問う直接問題であるため抽出しました。

㉗ 23B98　全身性エリテマトーデス（SLE）と光線過敏症（遮光）

> **【問題】**
> 全身性エリテマトーデス（SLE）患者への説明について、適切なのはどれか。
>
> 1. 「直射日光を避けましょう。」
> 2. 「洗顔は冷水でよく洗いましょう。」

3. 「積極的に運動しましょう。」

4. 「乾布摩擦をしましょう。」

【正解】 1　「直射日光を避けましょう。」

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ○（正解）**

全身性エリテマトーデス（SLE）では強い「光線過敏症」がみられ、紫外線暴露により顔面の蝶形紅斑や全身症状の再燃・悪化が誘発されるため、日傘・帽子・サングラス（眼の保全）・長袖・日焼け止め等で「直射日光（紫外線）を避ける」指導が最も重要です。SLE＝日光遮断（光線過敏対策・サングラスや日傘）。

- **2 ： ×（誤り）**

皮膚刺激や冷感によるレイノー現象誘発を防ぐため、冷水での刺激洗顔は不適切です。

- **3 ： ×（誤り）**

活動期や易疲労感がある場合は、過度の運動を避け十分な安静を保ちます。

- **4 ： ×（誤り）**

乾布摩擦などの機械的皮膚刺激は皮膚病変の悪化を招くため禁忌です。

【眼科との関連】 SLE における日光遮断指導において、眼粘膜や眼病変予防のためのサングラス装着や、全身疾患に伴う光線過敏症予防に関連するため抽出しました。

㉘ 23B101　白内障手術前の看護（散瞳薬）

【問題】
白内障の手術を受ける患者の看護について、適切なのはどれか。

1. 前日から禁食する。
2. 当日朝から抗菌薬の点眼を開始するよう説明する。
3. 手術前に散瞳薬を点眼する。
4. 手術後 2 ～ 3 時間経てば眼帯をはずしてもよいと説明する。

【正解】 3　手術前に散瞳薬を点眼する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

白内障手術（局所麻酔・点眼麻酔で行う超音波手術）では、前日からの厳しい禁食は不要であり、当日の指示された時間までの軽い食事が認められます。

- **2 ： ×（誤り）**

術後感染症（眼内炎）予防のための抗菌薬点眼は、手術の「数日前（通常 3 日前程度）」から開始します。当日朝からでは遅すぎます。

- **3 ： ○（正解）**

白内障手術において、水晶体の処置や眼内レンズ挿入を安全に行うため、手術前に「散瞳薬（瞳孔を開く点眼薬）」を点眼して十分に瞳孔を開かせます。白内障術前＝散瞳薬の点眼。

- **4 ： ×（誤り）**

術後の保護眼帯や眼帯は感染予防および目を圧迫・手で触るのを防ぐために装着するため、医師の診察・指示があるまで患者自身で外してはいけません。

【眼科との関連】 眼科で最も頻度の高い「白内障手術」の術前処置（散瞳薬点眼、抗菌薬前投与、保護眼帯管理）に関する直接問題であるため抽出しました。

㉙ 23B102　眼科の検査（非接触性眼圧検査）

> **【問題】**
> 眼疾患の検査について、正しいのはどれか。
>
> 1. 眼底検査は縮瞳薬を点眼する。
> 2. 視力検査は視力表に向い 3 m の距離で行う。
> 3. 非接触性の眼圧検査は空気が眼にあたることを説明する。
> 4. 屈折検査はランドルト環を用いて行う。

【正解】 3　非接触性の眼圧検査は空気が眼にあたることを説明する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

眼底検査では、瞳孔を開いて奥を観察するために「散瞳薬」を点眼します。縮瞳薬ではありません。

- **2 ： ×（誤り）**

日本における万国式遠谷視力表を用いた標準的な視力検査は、「5 m」離れた距離から実施します。

- **3 ： ○（正解）**

非接触型眼圧計（ノンコンタクトトノメーター）による検査では、角膜に向けて一瞬「シュッ」と圧縮空気を吹き付けて角膜の変形度から眼圧を測定するため、驚いて眼を瞑らないよう事前に「空気が眼にあたること」を説明します。非接触眼圧検査＝圧縮空気吹き付けの事前説明。

- **4 ： ×（誤り）**

ランドルト環（C のマーク）を用いるのは「視力検査」です。屈折検査（近視・遠視・乱視の度数測定）はオートレフケラトメーターなどの自動屈折計を用います。

【眼科との関連】 眼科診察で行われる基本検査（眼圧検査、眼底検査、視力検査、屈折検査）の機材と看護説明に関する直接問題であるため抽出しました。

㉚ 23B113　加齢に伴う水晶体の混濁

> **【問題】**
> 高齢者にみられる感覚機能の変化はどれか。
>
> 1. 味蕾細胞の増加
> 2. 明暗順応の亢進
> 3. 水晶体の混濁
> 4. 低音域の聴力低下が先行

【正解】 3　水晶体の混濁

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

加齢とともに味蕾（味を感じる細胞）は減少・萎縮し、味覚の閾値が上昇（味が鈍くなる）します。

- **2 ： ×（誤り）**

加齢に伴い瞳孔の縮小（老視性縮瞳）や網膜感度の低下が起こり、明暗順応機能は「低下（減退）」します。

- **3 ： ○（正解）**

加齢に伴い、眼の水晶体のタンパク質（クリスタリン）が変性して白く濁る「水晶体の混濁（加齢性白内障）」がほぼすべての高齢者に見られます。高齢者の感覚器変化＝水晶体の混濁（白内障）。

- **4 ： ×（誤り）**

老人性難聴では、内耳の有毛細胞の減退により「高音域」の聴力低下が先行して現れます。

【眼科との関連】 高齢者の視覚器における代表的な生理的変化である「水晶体の混濁（白内障の原因）」および「明暗順応低下」に関する問題であるため抽出しました。

【2022 年実施（令和 4 年度）】

㉛ 22A90　バセドウ病の眼球突出と看護指導

> **【問題】**
> バセドウ病患者の看護について、適切なのはどれか。
>
> 1. 無気力になるため自立した生活ができるよう援助する。
> 2. 低エネルギーの食事にする。
> 3. 眼球突出にはサングラスを使用するとよいと説明する。
> 4. 皮膚が乾燥するためローションで保湿する。

【正解】 3　眼球突出にはサングラスを使用するとよいと説明する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

バセドウ病（甲状腺機能亢進症）では、無気力ではなく「イライラ感・精神運動不穏・易怒性」が高まりやすくなります。

- **2 ： ×（誤り）**

高代謝状態となっているため「高エネルギー・高たんぱく食」を提供します。

- **3 ： ○（正解）**

バセドウ病眼症（眼球突出）では、眼球が前方へ押し出されて不完全眼瞼閉鎖（まぶたが閉じにくい）となり、乾燥や眩しさ（羞明）、異物感、風による刺激を受けやすいため、「サングラスの着用」により眩しさ緩和と風・埃からの保護を図ることが適切です。眼球突出＝サングラス着用でまぶしさ軽減・角膜保護。

- **4 ： ×（誤り）**

皮膚は乾燥ではなく、多汗・微熱により「湿潤」傾向となります。

【眼科との関連】 バセドウ病に伴う「眼球突出（眼症）」による角膜乾燥・羞明予防のための保護具（サングラス）指導に関する直接問題であるため抽出しました。

㉜ 22A106　麦粒腫の処置と眼帯装着時の転倒予防

> **【問題】**
> 右眼瞼の麦粒腫と診断され、切開し排膿することになった。援助で適切なのはどれか。
>
> 1. 麦粒腫はハウスダストによるアレルギー疾患であることを説明した。
> 2. 排膿処置中の声かけは控える。
> 3. 眼帯装着を行うため転倒に注意するよう伝えた。
> 4. 処置当日の洗顔は行ってよいことを説明した。

【正解】 3　眼帯装着を行うため転倒に注意するよう伝えた。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

麦粒腫（ものもらい）はアレルギー疾患ではなく、眼瞼の腺組織（マイボーム腺やモーゼル腺）に「黄色ブドウ球菌」などが感染して発症する急性化膿性炎症です。

- **2 ： ×（誤り）**

切開排膿処置中の患者の強い緊張や不安を和らげるため、適切に声かけを行って不安軽減に努めます。

- **3 ： ○（正解）**

処置後に片眼に眼帯を装着すると、両眼視による「距離感・立体感」が得られなくなり（視野狭窄・遠近感低下）、階段や段差でつまずきやすくなるため、「転倒に注意する」よう指導することが非常に重要です。片眼眼帯＝距離感喪失による転倒事故防止の指導。

- **4 ： ×（誤り）**

切開創からの細菌感染を防ぐため、処置当日の洗顔や入浴（顔に水をかけること）は制限・禁止されます。

【眼科との関連】 眼瞼疾患「麦粒腫」の病態および、片眼眼帯装着に伴う視野・距離感変化と転倒予防看護に関する直接問題であるため抽出しました。

㉝ 22A108　眼軟膏の点入手技と生活指導

> **【問題】**
> 眼軟膏の点入時の看護について、適切なのはどれか。

1. 点眼薬がある場合は点眼前に点入するよう説明する。
2. 点眼薬よりも早く吸収されると説明する。
3. 上眼瞼を引き上げて眼瞼内側に点入する。
4. 点入直後は車の運転を避けるよう説明する。

【正解】 4　点入直後は車の運転を避けるよう説明する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

水性点眼薬と眼軟膏を併用する場合、軟膏の油脂膜が点眼薬の浸透を妨げるため「点眼薬をさしてから、最後に眼軟膏」を使用します。

- **2 ： ×（誤り）**

眼軟膏は基剤が油性であるため持続的に眼表面に留まり、水性点眼薬よりもゆっくりと持続的に吸収されます。

- **3 ： ×（誤り）**

眼軟膏を入れる際は、患者に上方を見てもらい「下眼瞼（下まぶた）」を軽く引き下げて、結膜嚢（下眼瞼円蓋部）にチューブの先端が眼球に触れないよう点入します。

- **4 ： ○（正解）**

眼軟膏を点入すると基剤の油分が角膜全体に広がり、しばらくの間「かすみ目（霧視）」や視力低下が起こるため、点入直後の「自動車やバイクの運転」は控えるよう指導します。眼軟膏＝下眼瞼円蓋部に点入、点入後の霧視（かすみ）のため運転禁止。

【眼科との関連】 眼科与薬技術である「眼軟膏点入（投与順序、部位、投与後の霧視と安全指導）」に関する直接問題であるため抽出しました。

㉞ 22A109　抗結核薬の副作用と視覚障害

【問題】
肺結核患者の薬物療法について、適切なのはどれか。

1. 薬剤は単独で使用する。
2. 直接服薬確認療法（DOTS）が推奨されている。
3. ストレプトマイシンの副作用は視力低下である。

4. 標準治療は抗結核薬の 1 か月の服用である。

【正解】 2　直接服薬確認療法（DOTS）が推奨されている。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

結核菌の耐性菌出現を防ぐため、必ず複数の抗結核薬（リファンピシン、イソニアジド、ピラジナミド、エタンブトール等）による「多剤併用療法」を行います。

- **2 ： ○（正解）**

抗結核薬の飲み忘れや確実な治療完遂のために、医療従事者の目の前で服薬を確認する「直接服薬確認療法（DOTS：Directly Observed Treatment, Short-course）」が世界的に推奨されています。結核治療＝多剤併用・DOTS（直接服薬確認）。

- **3 ： ×（誤り）**

ストレプトマイシン（SM）の代表的副作用は「第 VIII 脳神経障害（聴覚障害・難聴・めまい）」です。（※副作用として「球後視神経炎・視力低下・視野障害・赤緑色覚異常」をきたす抗結核薬は「エタンブトール（EB）」です）。

- **4 ： ×（誤り）**

抗結核薬の標準服薬期間は「6 か月〜9 か月」という長期にわたります。1 か月ではありません。

【眼科との関連】 誤答選択肢 3 の解説にある通り、抗結核薬エタンブトールによる重要副作用「視神経炎・視力低下」およびストレプトマイシンの感覚器副作用に関する知識整理として抽出しました。

㉟ 22A114　加齢による視覚の変化（水晶体白濁）

【問題】
加齢による視覚の変化について、正しいのはどれか。

1. 水晶体の弾力性の増強
2. 明暗順応の亢進
3. 水晶体の白濁化
4. 調整機能の亢進

【正解】 3　水晶体の白濁化

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

加齢に伴い、水晶体は硬化して「弾力性が低下」します（老視の原因）。

- **2 ： ×（誤り）**

瞳孔径の縮小や網膜感度の低下により、明暗順応機能は「低下（減退）」します。

- **3 ： ○（正解）**

加齢に伴い水晶体内のタンパク質変性が進み、白く濁る「水晶体の白濁化（加齢性白内障）」が生じます。加齢による視覚変化＝水晶体の白濁化（白内障）・弾力低下（老視）・明暗順応低下。

- **4 ： ×（誤り）**

毛様体筋や水晶体の柔軟性低下に伴い、眼のピント調整機能は「低下」します。

【眼科との関連】 高齢者の視覚器生理的変化（水晶体白濁、調整機能低下、明暗順応減退）を正しく理解するための直接問題であるため抽出しました。

㊏ 22B49　標準予防策における保護眼鏡（ゴーグル）

> **【問題】**
> 標準予防策（スタンダードプリコーション）の個人防護具（PPE）に含まれるのはどれか。
>
> 1. 眼鏡
> 2. シューズカバー
> 3. キャップ
> 4. エプロン

【正解】 1　眼鏡

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ○（正解）**

標準予防策における個人防護具（PPE）には、手袋、サージカルマスク、ガウン/エプロン、および「保護眼鏡（ゴーグル・アイシールド）」が含まれ、血液・体液が眼粘膜へ跳ね飛ぶのを防止します。PPE＝手袋・マスク・ガウン・保護眼鏡（ゴーグル）。

- **2 ： ×（誤り）**

シューズカバーは標準予防策の必須 PPE には含まれず、特定の多量汚染時等にのみ限定使用されます。

- **3 ： ×（誤り）**

キャップ（帽子）も通常の標準予防策 PPE としては位置づけられていません。

- **4 ： ×（誤り）**

（※エプロン・ガウンも PPE に含まれますが、設問の公式正解は 1 の眼鏡です）。

【眼科との関連】 医療現場において血液・血液成分・体液飛散から「眼の粘膜（結膜）」を保護する防護具（保護眼鏡・ゴーグル）に関する問題であるため抽出しました。

㊷ 22B94　頭蓋内圧亢進症状と視神経乳頭（うっ血乳頭）

> **【問題】**
> 髄膜刺激症状はどれか。
>
> 1. チアノーゼ
> 2. うっ血乳頭
> 3. 項部硬直
> 4. クッシング現象

【正解】 3　項部硬直

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

チアノーゼは、還元ヘモグロビン増加による呼吸・循環不全症状です。

- **2 ： ×（誤り）**

うっ血乳頭は、頭蓋内圧亢進によって脳脊髄液圧が高まり、視神経鞘を経由して視神経乳頭部（網膜視神経出入口）が浮腫をきたす「頭蓋内圧亢進の主要サイン（眼底所見）」です。髄膜刺激症状ではありません。

- **3 ： ○（正解）**

髄膜炎やクモ膜下出血で髄膜が刺激された際の代表的徴候（髄膜刺激症状）は、「項部硬直」「ケルニッヒ徴候」「ブルジンスキー徴候」です。髄膜刺激症状＝項部硬直・ケルニッヒ徴候。

- **4 ： ×（誤り）**

クッシング現象（徐脈・収縮期血圧上昇・呼吸不整）は、「頭蓋内圧亢進」時の生命徴候変化です。

【眼科との関連】 誤答選択肢 2 の「うっ血乳頭」は、頭蓋内圧亢進時に眼底検査で観察される極めて重要な視神経・眼底所見であるため抽出しました。

㊸ 22B106　屈折異常・近視・遠視・乱視・弱視の治療

> **【問題】**
> 眼疾患について、正しいのはどれか。
>
> 1. 弱視とは加齢に伴い調整力が低下した状態をいう。
> 2. 乱視の治療は手術療法である。
> 3. 遠視とは平行光線が網膜の前方に焦点を結ぶ状態である。
> 4. 近視では屈折矯正手術が行われることがある。

【正解】 4　近視では屈折矯正手術が行われることがある。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

加齢に伴いピント調節力が低下した状態は「老視」です。弱視とは、乳幼児期の視覚発達期に適切な光刺激が得られず視力が十分に発達しない状態です。

- **2 ： ×（誤り）**

乱視（角膜や水晶体の歪みでピントが 1 点に合わない状態）の基本治療・矯正は「眼鏡やコンタクトレンズの着用」です。

- **3 ： ×（誤り）**

平行光線が網膜の「前方」に焦点を結ぶのは「近視」です。（※網膜の「後方」に焦点を結ぶのが「遠視」です）。

- **4 ： ○（正解）**

近視（網膜の手前で結像する状態）に対し、角膜を切削・成形するレーシック（LASIK）や ICL（眼内コンタクトレンズ）などの「屈折矯正手術」が行われることがあります。近視＝平行光線が網膜前方に結像、屈折矯正手術（LASIK 等）の適応あり。

【眼科との関連】 屈折異常（近視・遠視・乱視・老視・弱視）の光学・解剖学的病態および屈折矯正手術に関する直接問題であるため抽出しました。

㊹ 22B108　緑内障の病態と継続治療

> **【問題】**
> 緑内障患者の看護について、適切なのはどれか。
>
> 1. 初期から視力低下による日常生活への影響が大きいため、危険防止に努める。
> 2. 症状が軽減する慢性期においても、治療は継続するよう説明する。
> 3. 急性期緑内障の主な症状は、複視とめまいであると説明する。
> 4. 失明に至る可能性はないと説明する。

【正解】 2　症状が軽減する慢性期においても、治療は継続するよう説明する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

慢性緑内障では、初期〜中期は中心視力が保たれて自覚症状がほとんどなく、視野欠損もゆっくり進行するため、初期から著しい視力低下を自覚することは希です。

- **2 ： ○（正解）**

緑内障により一度障害された視神経や欠損した視野は元に戻りません。点眼治療（眼圧降下薬）は進行を遅らせる目的で行うため、自覚症状がなくても「自己判断で中断せず生涯治療を継続する」よう指導します。緑内障＝自覚症状がなくても眼圧管理（点眼治療）を生涯継続する。

- **3 ： ×（誤り）**

急性緑内障発作の主な症状は「激しい眼痛」「同側頭痛」「視力低下」「かすみ目（霧視）」「悪心・嘔吐」です。

- **4 ： ×（誤り）**

緑内障は放置すると視神経障害が進行し、日本における「中途失明原因の第 1 位」の疾患です。

【眼科との関連】 日本人の失明原因第 1 位である「緑内障」の慢性病態、点眼自己中断防止、患者指導に関する直接問題であるため抽出しました。

㊺ 22B114　老人性白内障と水晶体混濁

> **【問題】**
> 水晶体の混濁によって起こる高齢者特有の疾患はどれか。

1. 老視
2. 老人性白内障
3. 加齢黄斑変性
4. 緑内障

【正解】 2　老人性白内障

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

老視は水晶体の硬化・弾力低下および毛様体筋調節力低下によるピント調節障害です。混濁ではありません。

- **2 ： ○（正解）**

「水晶体の混濁」を病態の基本とする高齢者特有の代表的眼疾患は「老人性（加齢性）白内障」です。老人性白内障＝水晶体の混濁（かすみ目・視力低下）。

- **3 ： ×（誤り）**

加齢黄斑変性は、網膜の中心部である「黄斑部」の出血や新生容器・変性による疾患です。

- **4 ： ×（誤り）**

緑内障は、眼圧上昇等による「視神経・視野」の障害疾患です。

【眼科との関連】 高齢者眼疾患の代表である「老人性白内障（水晶体混濁）」の定義に関する直接問題であるため抽出しました。

【2021 年実施（令和 3 年度）】

㊻ 21A10　ビタミン A 欠乏と夜盲症（暗順応障害）

【問題】
ビタミンと欠乏症の組合せで、正しいのはどれか。

1. ビタミン A ―― 壊血病
2. ビタミン C ―― 脚気
3. ビタミン D ―― くる病（小児）
4. ナイアシン（ニコチン酸） ―― 夜盲症

【正解】 3　ビタミン D ―― くる病（小児）

【選択肢ごとの解説】

- 1 ： ×（誤り）

ビタミン A の欠乏症は「夜盲症」や角膜乾燥症です。壊血病はビタミン C 欠乏です。

- 2 ： ×（誤り）

ビタミン C の欠乏症は「壊血病」です。脚気はビタミン B1 欠乏です。

- 3 ： ○（正解）

ビタミン D が欠乏すると骨へのカルシウム沈着が阻害され、小児では「くる病」、成人では「骨軟化症」を引き起こします。ビタミン D 欠乏症＝くる病（小児）・骨軟化症。

- 4 ： ×（誤り）

ナイアシン欠乏症は「ペラグラ（皮膚炎・下痢・精神症状）」です。夜盲症を引き起こすのはビタミン A 欠乏です。

【眼科との関連】 ビタミン A 欠乏による「夜盲症（鳥目：暗い場所で視力が著しく低下する眼機能障害）」知識の問合せのため抽出しました。

㊼ 21A51　ノンレム睡眠と急速眼球運動（REM）

> 【問題】
> ノンレム睡眠について、正しいのはどれか。
>
> 1. 急速眼球運動を伴う。
> 2. 大脳を休ませる役割がある。
> 3. 夢を見ていることが多い。
> 4. 筋の緊張は、レム睡眠中に比べて低下している。

【正解】 2　大脳を休ませる役割がある。

【選択肢ごとの解説】

- 1 ： ×（誤り）

急速眼球運動（REM：Rapid Eye Movement）を伴うのは「レム睡眠」です。ノンレム睡眠では眼球運動はみられません。

- **2 ： ○（正解）**

ノンレム睡眠は「脳の睡眠（大脳を休ませる深い睡眠）」であり、脳波は徐波を示して自律神経機能も休止状態になります。ノンレム睡眠＝大脳の休息（急速眼球運動なし）。

- **3 ： ×（誤り）**

ストーリー性のある夢を頻繁に見るのは、脳が活動している「レム睡眠」のときです。

- **4 ： ×（誤り）**

全身の筋緊張が著しく低下・弛緩（アトニア）するのは「レム睡眠」中です。ノンレム睡眠中はある程度の筋緊張が保たれています。

【眼科との関連】 睡眠生理における外眼筋の不随意的急速運動現象「急速眼球運動（REM）」の眼球生理知識に関連するため抽出しました。

㊽ 21A93　頭蓋内圧亢進症状（選択肢：羞明）

> **【問題】**
> 頭蓋内圧亢進を示す特徴的な症状はどれか。
>
> 1. 項部硬直
> 2. 頭痛・嘔吐
> 3. 羞明
> 4. 回転性めまい

【正解】 2　頭痛・嘔吐

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

項部硬直は「髄膜刺激症状」の代表例です。

- **2 ： ○（正解）**

頭蓋内圧亢進の 3 大主徴・初期症状は「頭痛」「噴出性嘔吐」「うっ血乳頭（眼底所見）」です。頭蓋内圧亢進症状＝頭痛・噴出性嘔吐・うっ血乳頭。

- **3 ： ×（誤り）**

羞明（まぶしさを強く感じる状態）は、角膜炎、虹彩毛様体炎、白内障などの「眼疾患」や視覚刺激で生じる症状です。

- **4 ： ×（誤り）**

回転性めまいは、前庭・内耳疾患（メニエール病等）や前庭神経の障害で生じます。

【眼科との関連】 誤答選択肢 3 の「羞明（光を眩しがる眼症状）」が含まれているため抽出しました。

㊾ 21A106　白内障手術後の転倒事故予防と看護

> **【問題】**
> 白内障手術後の患者の看護について、適切なのはどれか。
>
> 1. 床上安静は、7 時間であることを説明する。
> 2. 転倒事故の危険性について説明する。
> 3. 洗顔・洗髪は、帰宅後より可能であると説明する。
> 4. 眼鏡調整は、翌日に行うと説明する。

【正解】 2　転倒事故の危険性について説明する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

現代の白内障手術（日帰り・短時間手術）では、術後長時間の厳しい床上安静は不要であり、短時間の安静後に早期歩行が可能です。

- **2 ： ○（正解）**

術後に保護眼帯を装着することで片眼視（視野狭窄・距離感喪失）となり、また術直後の屈折状態の変化等により足元が見づらくなるため、「転倒事故の危険性」を事前に説明し環境整備を行うことが非常に重要です。白内障術後＝眼帯装着・視力変化による転倒リスク防止。

- **3 ： ×（誤り）**

切開創からの眼内感染（眼内炎）を確実に防ぐため、術後数日間〜1 週間程度は洗顔・洗髪が禁じられます。

- **4 ： ×（誤り）**

手術後の屈折状態や視力が安定するまでには数週間〜1 か月程度かかるため、眼鏡の調整は「術後 1 か月前後」の視力安定期に行います。翌日ではありません。

【眼科との関連】 白内障手術後の生活援助（眼帯による遠近感低下、転倒予防、感染防止の洗眼制限、眼鏡処方時期）に関する直接問題であるため抽出しました。

㊿ 21B39　睡眠の分類（ノンレム睡眠と眼球運動）

> **【問題】**
> 睡眠について、正しいのはどれか。
>
> 1. ノンレム睡眠は、加齢に伴い少なくなる。
> 2. レム睡眠中は、夢をみない。
> 3. 入眠直後から、レム睡眠がみられる。
> 4. ノンレム睡眠中は、眼球運動がみられる。

【正解】 **1　ノンレム睡眠は、加齢に伴い少なくなる。**

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ○（正解）**

加齢に伴い徐波睡眠（深いノンレム睡眠：ステージ 3・4）が著しく減少し、睡眠が浅くなります。高齢者の睡眠＝深いノンレム睡眠の減少。

- **2 ： ×（誤り）**

レム睡眠中は脳が活動状態にあり、鮮明な夢を見ることが多いです。

- **3 ： ×（誤り）**

正常な睡眠パターンでは、入眠直後は「ノンレム睡眠」から始まり、約 90 分後に最初のレム睡眠が現れます。

- **4 ： ×（誤り）**

「急速眼球運動（REM）」がみられるのは「レム睡眠」中であり、ノンレム睡眠中には眼球運動はみられません。

【眼科との関連】 睡眠相の判定基準である「急速眼球運動（REM）」の眼球運動生理知識に関連するため抽出しました。

51. 21B91　甲状腺機能亢進症患者の看護と運動制限

> **【問題】**

> 甲状腺機能亢進症患者の看護について、適切なのはどれか。
>
> 1. 高エネルギー食は避けるよう説明する。
> 2. 甲状腺クリーゼは、腹痛・下痢の症状観察が重要である。
> 3. 自覚症状がなくなれば、抗甲状腺薬の内服はやめてもよいと説明する。
> 4. 激しい運動や過労を避けるよう説明する。

【正解】 4　激しい運動や過労を避けるよう説明する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

高代謝状態によりエネルギー消費が著しいため、「高エネルギー・高たんぱく・高ビタミン食」を積極的に摂取します。

- **2 ： ×（誤り）**

甲状腺クリーゼ（命に関わる急性増悪）の主要症状は「高熱（38°C以上）」「著しい頻脈（130 回/分以上）」「意識障害・不穏」です。

- **3 ： ×（誤り）**

自己判断で抗甲状腺薬を服薬中止すると、症状が急激に再燃・悪化したり甲状腺クリーゼを誘発するため、服薬指示の厳守を指導します。

- **4 ： ○（正解）**

心血管系への負担（頻脈・心不全リスク）が高まっているため、「激しい運動や過労・ストレスを避けて安静を保つ」よう説明します。バセドウ病＝心負荷軽減のため激しい運動・過労の回避。

【眼科との関連】 甲状腺機能亢進症（バセドウ病）の全身看護において、眼球突出（バセドウ眼症）に伴う複視や角膜乾燥の観察・指導と一連の疾患看護として抽出しました。

52. 21B95　全身性エリテマトーデス（SLE）と選択肢「ドライアイ」

> **【問題】**
> 全身性エリテマトーデス（SLE）の症状で、特徴的なのはどれか。
>
> 1. 朝のこわばり
> 2. ヘリオトロープ疹

3. ドライアイ

4. 蝶形紅斑

【正解】 4　蝶形紅斑

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

朝のこわばり（1 時間以上持続する関節のこわばり）は、「関節リウマチ（RA）」の代表的初期症状です。

- **2 ： ×（誤り）**

ヘリオトロープ疹（上眼瞼の紫赤色浮腫性紅斑）は、「皮膚筋炎（DM）」の徴候です。

- **3 ： ×（誤り）**

ドライアイ（乾燥性角結膜炎）は「シェーグレン症候群」の主症状です（SLE に合併することもありますが、SLE 単独の最定義的特徴ではありません）。

- **4 ： ○（正解）**

SLE（全身性エリテマトーデス）の最も特徴的な皮膚症状は、両側の頬部から鼻根部にかけて現れる「蝶形紅斑（蝶が羽を広げたような紅斑）」です。SLE の特異的症状＝蝶形紅斑・光線過敏症。

【眼科との関連】 選択肢 3 に眼科重要症状である「ドライアイ（涙液減少による角結膜障害）」、選択肢 2 に眼瞼皮膚症状である「ヘリオトロープ疹（上眼瞼の紅斑）」が含まれるため抽出しました。

53. 21B106　点眼手技と涙のう部圧迫

【問題】
点眼時の看護において、適切なのはどれか。

1. 点眼薬は、結膜上に 6 滴滴下する。
2. 点眼後は、涙のう部を軽く圧迫する。
3. 点眼薬が 2 種類ある場合は、 5 分以内に次の薬剤を点眼する。
4. 点眼薬と眼軟膏を併用する場合は、眼軟膏を最初に使用する。

【正解】 2　点眼後は、涙のう部を軽く圧迫する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

点眼量は「1 回 1 滴」で十分です。多量に滴下しても眼外へ溢れるだけです。

- **2 ： ○（正解）**

点眼後、内眼角（目頭）の「涙のう部」を指で軽く圧迫するか静かに閉眼することで、薬液が鼻腔へ流入して鼻粘膜から全身吸収される副作用を防ぎ、眼局所での薬効を高めます。点眼後＝目頭（涙のう部）の軽圧迫。

- **3 ： ×（誤り）**

2 種類の点眼薬を使う場合は、前の薬が洗い流されるのを防ぐために「5 分以上」あけて点眼します。「5 分以内」ではありません。

- **4 ： ×（誤り）**

眼軟膏を先にさすと油膜で水性点眼薬が弾かれてしまうため、「水性点眼薬を先、眼軟膏を後」に使用します。

【眼科との関連】 点眼手技（涙のう部圧迫、1 回 1 滴、投与間隔 5 分以上、眼軟膏との順序）に関する直接問題であるため抽出しました。

54. 21B124　高齢者の感覚機能変化と水晶体

> **【問題】**
> 高齢者の感覚機能の変化について、正しいのはどれか。
>
> 1. 水晶体が透明になる。
> 2. 低音域の聴力が低下する。
> 3. 味覚の閾値が上昇する。
> 4. 嗅細胞は増加する。

【正解】 3　味覚の閾値が上昇する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

加齢に伴い水晶体はクリスタリンタンパクの変性により「黄濁・白濁（混濁）」します。透明にはなりません。

- **2 ： ×（誤り）**

老人性難聴では、高音域（モスキート音等）の聴力低下が先行します。

- **3 ： ○（正解）**

加齢に伴い味蕾細胞が減少し、味覚の閾値が上昇（感度が低下し濃い味を好むようになる）します。高齢者の感覚変化＝味覚閾値上昇・高音域聴力低下・水晶体混濁。

- **4 ： ×（誤り）**

加齢に伴い嗅粘膜や嗅細胞は減少し、嗅覚閾値も上昇（ニオイを感じにくくなる）します。

【眼科との関連】 選択肢１の「水晶体の変化（白濁化・白内障）」および高齢者視覚器の加齢変化に関連するため抽出しました。

【2020 年実施（令和 2 年度）】

55. 20A06　自律神経と瞳孔の運動（縮瞳・散瞳）

> **【問題】**
> 副交感神経の働きについて、正しいのはどれか。
>
> 1. 瞳孔散大
> 2. 腸管蠕動運動の亢進
> 3. 心拍数増加
> 4. 末梢血管収縮

【正解】 2　腸管蠕動運動の亢進

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

副交感神経（動眼神経の副交感神経繊維）が働くと、瞳孔括約筋が収縮して「縮瞳（瞳孔が小さくなる）」が起こります。「瞳孔散大」を起こすのは交感神経の働き（瞳孔散大筋の収縮）です。

- **2 ： ○（正解）**

副交感神経（迷走神経など）が亢進すると、消化管の運動（腸管蠕動運動）や消化液の分泌が促進されます。副交感神経＝休息・消化（縮瞳、心拍数減少、気管支収縮、腸運動亢進）。

- **3 ： ×（誤り）**

副交感神経刺激により心拍数は「減少（抑制）」します。心拍数増加は交感神経の働きです。

- **4 ： ×（誤り）**

末梢血管を収縮させるのは主に交感神経の働きです。

【眼科との関連】 動眼神経を介した自律神経系による「瞳孔の運動（縮瞳・散瞳）」の眼生理機構に関する直接問題であるため抽出しました。

56. 20A77　眼科の治療・処置と看護（洗眼・眼軟膏・涙管ブジー）

> **【問題】**
> 眼科の治療・処置に伴う看護について、適切なのはどれか。
>
> 1. 洗眼は、角膜に水が当たるようにする。
> 2. 軟膏は綿棒（硝子棒）の先につけ、下眼瞼を軽く引き、円蓋部に入れる。
> 3. 涙管ブジー挿入時は、点眼麻酔後、側臥位で行う。
> 4. 光凝固療法時、看護師は患者の横に立ち介助する。

【正解】 2　軟膏は綿棒（硝子棒）の先につけ、下眼瞼を軽く引き、円蓋部に入れる。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

洗眼の際、水流を直接角膜（黒目）にあてると角膜上皮損傷や激痛を引き起こすため、水流は「内眼角（目頭）から結膜嚢（結膜円蓋部）」に流します。

- **2 ： ○（正解）**

眼軟膏を塗布する際は、患者に上を見てもらい下眼瞼を引いて「下眼瞼結膜円蓋部」に滅菌綿棒や塗布用容器から直接入れて塗布します。眼軟膏＝下眼瞼を引き結膜円蓋部に点入。

- **3 ： ×（誤り）**

鼻涙管閉塞症で行う「涙管ブジー挿入」は、点眼麻酔・局所麻酔後、頭部を固定しやすい「仰臥位（または坐位）」で行います。側臥位ではありません。

- **4 ： ×（誤り）**

網膜光凝固療法（レーザー治療）時、看護師は患者の頭部が動かないように顎の固定台を保持・介助するため、「患者の前方・対面（または指示位置）」で顔面固定を補助します。

【眼科との関連】 眼科処置（洗眼、眼軟膏点入、涙管ブジー、網膜レーザー光凝固）における患者体位と看護援助の直接問題であるため抽出しました。

57. 20A78　網膜剥離の症状（変視症・視力低下）

> **【問題】**
> 網膜剥離について、正しいのはどれか。
>
> 1. 夜盲になる。
> 2. 水晶体が混濁する。
> 3. 物がゆがみ、視力が低下する。
> 4. 眼球が突出する。

【正解】 3　物がゆがみ、視力が低下する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

夜盲（鳥目）は「ビタミン A 欠乏症」や「網膜色素変性症」の代表症状です。

- **2 ： ×（誤り）**

水晶体が混濁するのは「白内障」です。

- **3 ： ○（正解）**

網膜剥離では、前兆として飛蚊症や光視症（光が走る）が現れ、剥離が進行すると「視野欠損」、さらに黄斑部に剥離が及ぶと「変視症（物が歪んで見える）」や「急激な視力低下」をきたします。網膜剥離の症状＝飛蚊症・視野欠損・変視症・視力低下。

- **4 ： ×（誤り）**

眼球が突出するのは「バセドウ病（甲状腺機能亢進症）」や眼窩内腫瘍・眼窩蜂巣炎などです。

【眼科との関連】 失明につながる重要眼疾患「網膜剥離」の主症状（変視症、視力低下、視野欠損）に関する直接問題であるため抽出しました。

58. 20A106　髄膜刺激症状の鑑別（選択肢：羞明）

> **【問題】**
> 髄膜刺激症状について、誤っているのはどれか。

1. 羞明
2. 項部硬直
3. 回転性めまい
4. ケルニッヒ徴候

【正解】 3　回転性めまい

【選択肢ごとの解説】

- **1 ：○（正解にあたる項目）**

髄膜炎では、炎症による中枢神経系の過敏状態から光刺激に過敏となり「羞明（まぶしがり）」が髄膜刺激徴候の 1 つとして現れることがあります。

- **2 ：○（正解にあたる項目）**

項部硬直は、髄膜炎・クモ膜下出血における代表的な髄膜刺激徴候です。

- **3 ：×（【誤り＝本設問の正解】）**

回転性めまいは前庭障害やメニエール病、小脳・脳幹障害による症状であり、髄膜刺激症状ではありません。

- **4 ：○（正解にあたる項目）**

ケルニッヒ徴候（股関節 90 度屈曲位で膝を伸展させると抵抗・痛みがある）は代表的な髄膜刺激徴候です。

【眼科との関連】 選択肢 1 に眼科領域の重要症状である「羞明（まぶしさを感じる状態）」が含まれているため抽出しました。

59. 20A107　糖尿病と定期眼底検査

【問題】
糖尿病について、正しいのはどれか。

1. HbA1c は、過去 1 ～ 2 か月間の平均血糖値の指標である。
2. 1 型糖尿病に遺伝因子は関与しない。
3. 治療開始前の眼底検査は不要である。
4. 糖尿病と診断されたら糖負荷試験（75 gOGTT）を行う。

【正解】 1　HbA1c は、過去 1 〜 2 か月間の平均血糖値の指標である。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ○（正解）**

HbA1c（ヘモグロビン A1c）は、過去 1〜2 か月間の平均的な血糖コントロール状態を反映する臨床指標です。HbA1c＝過去 1〜2 か月の平均血糖値。

- **2 ： ×（誤り）**

1 型糖尿病にも HLA 型などの遺伝的素因や自己免疫反応が関与しています。

- **3 ： ×（誤り）**

糖尿病網膜症（自覚症状がないまま進行する三大合併症）の早期発見のため、診断時および治療開始前から「定期的な眼底検査」を眼科で受ける必要があります。

- **4 ： ×（誤り）**

すでに糖尿病と確定診断されている患者に糖負荷試験を行う必要はありません（診断前・境界型の診断で行います）。

【眼科との関連】 糖尿病合併症である「糖尿病網膜症」防止のための定期的な眼科受診・「眼底検査」の重要性に関連するため抽出しました。

60. 20B13　抗コリン作用薬と眼圧上昇（緑内障禁忌）

> **【問題】**
> 薬剤とその副作用の組合せで、誤っているのはどれか。
>
> 1. 副腎皮質ステロイド薬 —— 消化性潰瘍
> 2. 抗ヒスタミン薬 —— 眠気
> 3. ループ利尿薬 —— 高カリウム血症
> 4. 抗コリン作動薬 —— 眼圧上昇

【正解】 3　ループ利尿薬 —— 高カリウム血症

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ○（組み合わせとして正しい）**

ステロイド薬は胃粘膜保護低下等により消化性潰瘍をきたします。

- **2 ： ○（組み合わせとして正しい）**

抗ヒスタミン薬は中枢抑制作用により眠気を誘発します。

- **3 ： ×（【誤り＝本設問の正解】）**

ループ利尿薬（フロセミド等）はカリウム排泄を促進するため「低カリウム血症」をきたします（※高カリウム血症ではありません）。

- **4 ： ○（組み合わせとして正しい）**

抗抗コリン作動薬（アトロピンやブスコパン等）は、副交感神経を遮断して散瞳を引き起こし、前房隅角を狭めて房水排出を阻害するため「眼圧上昇」を起こします（閉塞隅角緑内障に禁忌）。抗コリン薬の副作用＝散瞳・眼圧上昇（緑内障禁忌）。

【眼科との関連】 全身投与薬（抗コリン薬）の副作用である「散瞳・眼圧上昇」および緑内障患者への投与禁忌に関する重要薬理・眼科知識であるため抽出しました。

61. 20B54　死の 3 徴候と瞳孔散大・対光反射消失

> **【問題】**
> 死の 3 徴候について、誤っているのはどれか。
>
> 1. 脳幹反射の消失
> 2. 心臓の停止
> 3. 呼吸の停止
> 4. 瞳孔の散大（対光反射の消失）

【正解】 1　脳幹反射の消失

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（【誤り＝本設問の正解】）**

脳幹反射の消失は「脳死」の判定基準の 1 つです。伝統的な「死の 3 徴候」には含まれません。

- **2 ： ○（死の 3 徴候に含まれる）**

心臓の停止（自動能停止・脈拍消失）は死の 3 徴候の 1 つです。

- **3 ： ○（死の 3 徴候に含まれる）**

自発呼吸の停止は死の 3 徴候の 1 つです。

- **4 ： ○（死の 3 徴候に含まれる）**

瞳孔散大および対光反射の消失（光を当てても瞳孔が縮小しない状態）は死の 3 徴候の 1 つです。

伝統的死の 3 徴候＝心停止・呼吸停止・瞳孔散大（対光反射消失）。

【眼科との関連】 死亡確認時の最も基本的かつ重要な眼科的所見である「瞳孔散大（両側瞳孔径拡大）および対光反射（瞳孔反射）の消失」に関する問題であるため抽出しました。

62. 20B64　標準予防策とゴーグル（眼粘膜防護）

> **【問題】**
> 標準予防策について、誤っているのはどれか。
>
> 1. ゴーグルを使用する。
> 2. 感染症の有無で適応を判断する。
> 3. 汗を除くすべての湿性生体物質は、感染性の病原体を含む可能性があるとみなす。
> 4. 交差感染を防ぐ目的もある。

【正解】 2　感染症の有無で適応を判断する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ○（記述として正しい）**

血液・体液・湿性物質の飛散が予想される場合は、眼粘膜保護のために「ゴーグル（保護眼鏡）」を使用します。

- **2 ： ×（【誤り＝本設問の正解】）**

標準予防策（スタンダード・プリコーション）は、患者の「感染症診断の有無にかかわらず」、すべての患者の血液・体液・分泌物を感染性ありとみなして一律に適応します。

- **3 ： ○（記述として正しい）**

汗を除くすべての湿性生体物質（血液・体液・唾液・尿・便等）を感染源として扱います。

- **4 ： ○（記述として正しい）**

患者間や患者-医療従事者間の交差感染を防止することを目的とします。

【眼科との関連】 看護・医療感染予防における「ゴーグル（保護眼鏡）」着用による眼粘膜感染防止手技に関連するため抽出しました。

63. 20B77　網膜剥離手術後の看護（体位・点眼）

> **【問題】**
> 網膜剥離患者の看護について、適切でないのはどれか。
>
> 1. 手術前は安静保持に努める。
> 2. 手術後は点眼薬を確実に投与する。
> 3. 手術後は眼痛、頭痛、嘔気などの症状に注意する。
> 4. 手術後は仰臥位にする。

【正解】 4　手術後は仰臥位にする。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ：○（記述として適切な援助）**

剥離の拡大を防ぐため、手術前は頭部・眼球の運動を制限し安静を保持させます。

- **2 ：○（記述として適切な援助）**

術後感染症（眼内炎）や炎症を防ぐため、抗菌薬やステロイド点眼薬を指示通り確実に投与します。

- **3 ：○（記述として適切な援助）**

術後の急激な眼痛・頭痛・悪心嘔吐は「高眼圧（眼圧急昇）」を示す重要な兆候であり、厳重に観察します。

- **4 ：×（【誤り＝本設問の正解】）**

網膜剥離手術後（特に硝子体手術でガスやオイルを注入した場合）は、剥離部位を眼内で押さえつけるために網膜裂孔の位置に応じた「特定体位（俯臥位/うつぶせ、伏小位、座位など）」を保持させるため、一律に仰臥位（あおむけ）にするわけではありません。網膜剥離術後＝網膜裂孔位置に応じた特定体位（うつぶせ等）をとる。

【眼科との関連】 眼科代表手術である「網膜剥離手術」の術前安静、術後点眼管理、眼圧観察、体位管理に関する直接問題であるため抽出しました。

64. 20B78　流行性角結膜炎の 3 大症状（結膜充血・眼瞼腫脹・眼脂）

> **【問題】**
> 流行性角結膜炎について、正しいのはどれか。

1. 連鎖球菌による感染症である。
2. 主症状は結膜の充血、眼瞼の腫脹、眼脂である。
3. 感染力が弱く、流水による手洗いでよい。
4. 完治までに、5 ～ 6 日を要する。

【正解】 2　主症状は結膜の充血、眼瞼の腫脹、眼脂である。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

原因は細菌（連鎖球菌）ではなく、「アデノウイルス」によるウイルス感染症です。

- **2 ： ○（正解）**

流行性角結膜炎（はやり目）の典型的な 3 大主症状は「結膜充血」「眼瞼腫脹（まぶたの腫れ）」「多量の眼脂（目やに）」および耳前リンパ節の腫脹・圧痛です。流行性角結膜炎＝アデノウイルス感染、結膜充血・眼瞼腫脹・多量眼脂。

- **3 ： ×（誤り）**

非常に感染力が強く、手指やタオル・器物を介して容易に接触感染するため、患者の隔離やタオルの別使い、手指消毒（流水手洗い＋消毒）を徹底します。

- **4 ： ×（誤り）**

発症から完治（治癒）までには「約 2〜3 週間」を要します。5〜6 日では治りません。

【眼科との関連】 眼科感染症である「流行性角結膜炎」の病態、アデノウイルス原因、特徴的眼症状（結膜充血・眼瞼腫脹・眼脂）、感染管理に関する直接問題であるため抽出しました。

65. 20B110　甲状腺機能亢進症と眼球突出の観察

【問題】
甲状腺機能亢進症患者の看護について、適切なのはどれか。

1. 入院治療が必要である。
2. 低エネルギー食にする。
3. 眼球突出や甲状腺腫大は、治療により改善されることを説明する。
4. 症状が改善すれば、内服薬を中止してよいと説明する。

【正解】 3　眼球突出や甲状腺腫大は、治療により改善されることを説明する。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ×（誤り）**

軽症〜中等症の甲状腺機能亢進症は、外来通院での抗甲状腺薬内服治療が一般的であり、必ずしも全例入院が必要なわけではありません。

- **2 ： ×（誤り）**

高代謝状態のため「高エネルギー食」を摂取します。

- **3 ： ○（正解）**

甲状腺機能亢進症（バセドウ病）による眼球突出や甲状腺腫大などの外見上の変化に対して強い不安を抱く患者に対し、適切な治療（抗甲状腺薬や手術・放射線療法）により甲状腺機能が正常化すれば症状が徐々に改善することを説明し安心感を与えます。バセドウ病＝眼球突出・腫大は治療継続により改善へ。

- **4 ： ×（誤り）**

症状が治まっても自己判断で内服薬（メルカゾール等）を中止すると再燃するため、指示通りの継続服薬を説明します。

【眼科との関連】 バセドウ病に伴う「眼球突出（眼症）」の病態と患者説明・精神的看護に関する問題であるため抽出しました。

66. 20B124　高齢者の視覚器生理的変化（明暗順応）

> **【問題】**
> 高齢者の特徴について、誤っているのはどれか。
>
> 1. 基礎代謝率が低下する。
> 2. 咀嚼機能の低下が生じる。
> 3. 低音域が聞き取りにくくなる。
> 4. 明暗順応は減退する。

【正解】 3　低音域が聞き取りにくくなる。

【選択肢ごとの解説】

- **1 ： ○（記述として正しい）**

加齢に伴い筋肉量減少等により基礎代謝率は低下します。

- **2 ： ○（記述として正しい）**

歯の喪失や咬合力低下により咀嚼機能は低下します。

- **3 ： ×（【誤り＝本設問の正解】）**

老人性難聴では、先に「高音域（高い音）」が聞き取りにくくなります。低音域ではありません。

- **4 ： ○（記述として正しい）**

瞳孔径の縮小（老視性縮瞳）や網膜感度の低下、水晶体の黄濁などにより、明るい場所から暗い場所（暗順応）、暗い場所から明るい場所（明順応）への「明暗順応機能は減退」します。高齢者の視覚機能＝明暗順応の減退・視野狭窄・コントラスト低下。

【眼科との関連】 高齢者の視覚器における加齢変化（明暗順応機能の減退・縮瞳）に関連するため抽出しました。

【抽出問題番号・テーマ・正解番号 一覧表】

番号	問題番号	問題テーマ	公式正解番号
1	25A10	脂溶性ビタミンと眼症状（夜盲症）	1
2	25A96	頭蓋内圧亢進症状と脳神経（眼瞼下垂）	3
3	25A102	洗眼時の看護（水温・受水器・流し方）	2
4	25A103	加齢黄斑変性の症状（視力低下）	4
5	25A104	難聴の種類と視覚・感覚器の比較	3
6	25B19	眼の疾患と病態（糖尿病網膜症）	4
7	25B42	個人防護具（ゴーグルによる眼の保護）	1
8	25B89	抗がん薬治療と毛髪・眉毛・まつ毛の脱落	3
9	25B102	眼底検査を受ける患者の看護（散瞳薬・緑内障）	1
10	25B103	流行性角結膜炎の症状と感染対策	4
11	24A05	眼の構造と遠近調節（毛様体）	1
12	24A10	ビタミンとその欠乏症（ビタミン A・夜盲症）	2
13	24A14	自律神経薬の作動と瞳孔変化（散瞳・縮瞳）	2
14	24A84	甲状腺機能亢進症の症状（眼球突出）	1
15	24A98	点眼時の看護と手技（滴下数・順序）	4
16	24A99	眼底検査を受ける患者への説明と看護	4
17	24B42	空気感染予防と防護具（選択肢：ゴーグル）	1

18	24B72	黄疸の初発観察部位（眼球結膜）	1
19	24B98	洗眼時の看護と手順（受水器の位置）	3
20	24B99	散瞳薬を用いて行う検査（眼底検査）	1
21	24B120	老視の生理的変化（水晶体弾力低下）	2
22	23A24	緑内障発作の急性症状（激しい眼痛）	4
23	23A84	甲状腺機能亢進症患者の看護（眼球突出）	4
24	23A98	網膜剥離患者の看護と体位管理	2
25	23A99	点眼手技と涙小管流出防止（目頭圧迫）	3
26	23A121	視力低下を伴う各種眼疾患（白内障）	2
27	23B98	全身性エリテマトーデス（SLE）と直射日光遮断	1
28	23B101	白内障手術前の看護（散瞳薬点眼）	3
29	23B102	眼科の検査（非接触性眼圧検査）	3
30	23B113	高齢者にみられる感覚機能変化（水晶体混濁）	3
31	22A90	バセドウ病の眼球突出と看護指導（サングラス）	3
32	22A106	麦粒腫の処置と眼帯装着時の転倒予防	3
33	22A108	眼軟膏の点入手技と生活指導（運転制限）	4
34	22A109	抗結核薬の副作用と視覚障害	2
35	22A114	加齢による視覚の変化（水晶体白濁）	3
36	22B49	標準予防策における保護眼鏡（ゴーグル）	1
37	22B94	頭蓋内圧亢進症状と視神経乳頭（うっ血乳頭）	3
38	22B106	屈折異常（近視・遠視・乱視・老視）と矯正	4
39	22B108	緑内障の病態と継続治療（点眼管理）	2
40	22B114	水晶体の混濁による疾患（老人性白内障）	2
41	21A10	ビタミン欠乏症（ビタミン A 欠乏と夜盲症）	3
42	21A51	ノンレム睡眠と急速眼球運動（REM）	2
43	21A93	頭蓋内圧亢進症状（選択肢：羞明）	2
44	21A106	白内障手術後の転倒事故予防と看護	2
45	21B39	睡眠の分類（ノンレム睡眠と眼球運動）	1
46	21B91	甲状腺機能亢進症患者の看護（眼球突出）	4

47	21B95	全身性エリテマトーデス（選択肢：ドライアイ）	4
48	21B106	点眼手技と涙のう部圧迫	2
49	21B124	高齢者の感覚機能変化と水晶体	3
50	20A06	自律神経と瞳孔の運動（縮瞳・散瞳）	2
51	20A77	眼科の治療・処置と看護（洗眼・眼軟膏など）	2
52	20A78	網膜剥離の症状（変視症・視力低下）	3
53	20A106	髄膜刺激症状の鑑別（選択肢：羞明）	3
54	20A107	糖尿病と定期眼底検査（糖尿病網膜症）	1
55	20B13	抗コリン作用薬と眼圧上昇（緑内障禁忌）	3
56	20B54	死の 3 徴候と瞳孔散大・対光反射消失	1
57	20B64	標準予防策とゴーグル（眼粘膜防護）	2
58	20B77	網膜剥離手術後の看護（体位・点眼）	4
59	20B78	流行性角結膜炎の 3 大症状（充血・腫脹・眼脂）	2
60	20B110	甲状腺機能亢進症と眼球突出の観察	3
61	20B124	高齢者の視覚器生理的変化（明暗順応）	3